

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5028508-65.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE LINHARES
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5028508-65.2024.4.02.5001

500003473966 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5028508-65.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE LINHARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela União em face da decisão do evento 3, que indeferiu a inicial.

Alega a agravante o que segue:

Em síntese, o magistrado dos Juizados Especiais Federais acolheu a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação judicial declinada da Justiça Estadual envolvendo o fornecimento de medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Embora a demanda tenha sido ajuizada perante a Justiça Estadual e em face tão somente de entes federativos diversos, o juízo de direito atuou de ofício para incluir a União Federal no polo passivo e o juízo do Juizado Especial Federal acolheu a competência indevidamente declinada.

Sendo assim, o ato judicial impugnado não encontra qualquer embasamento na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.178/SE) e viola os dispositivos da legislação processual civil a respeito da incompetência absoluta (artigos 44, 45 e 64 do CPC), do litisconsórcio necessário (art.114 do CPC), da coisa julgada (art. 506 do CPC) e da necessidade de observância das teses vinculantes (art. 927 do CPC), bem como atenta contra diversas normas de índole constitucional (art. 2º, inciso I do art. 109, art. 196 e art. 198 da CRFB/88).

A fim de ilidir qualquer celeuma a respeito do cabimento do writ, importa destacar as seguintes considerações:

a) As Turmas Recursais que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região estão modificando entendimentos outros para desacolher a competência da Justiça Federal e determinar a devolução dos autos à Justiça Estadual desde a publicação do inteiro teor do acórdão proferido no RE 855.178/SE (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal);

b) O Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da inexistência de litisconsórcio passivo necessário em casos envolvendo medicamentos com registro na ANVISA não incorporados ao Sistema Único de Saúde - SUS;

c) Haveria prejuízo irreversível ao processo judicial na eventualidade de a análise da competência da Justiça Federal ser postergada para o ato de processamento e julgamento de recurso nominado, seja quanto ao cumprimento descabido de tutelas provisórias de urgência deferidas contra a União Federal ou quanto às consequências do atraso que recairão sobre o usuário do sistema público de saúde;

Considerando ainda que o objeto do writ é qualificado como matéria de ordem pública, notadamente cognoscível até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, a União Federal requer o conhecimento do presente mandado de segurança para que os atos sejam restituídos à Justiça Estadual.

(...)

Em relação à remessa massiva de ações judiciais envolvendo medicamentos para a Justiça Estadual para a Justiça Estadual, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o IAC nº 14 e exarou a seguinte decisão:

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. **Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. **Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida”** (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022 - gn)**

Nesse mesmo IAC, e em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), **o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.**

Posteriormente, a mesma Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, e em sintonia com o entendimento de que a competência para processamento de tais feitos seria mesmo da Justiça Estadual (que estaria impedida da “declinação de competência nas ações que versem sobre o tema”), entendeu que inexistia litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, sendo, portanto, ilegítima a decisão que determina sua inclusão obrigatória nos feitos em que se objetiva a concessão de medicamentos não incorporados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MEDICAMENTO DE USO “OFF LABEL”, PORÉM REGISTRADO NA ANVISA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 150, 224 e 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Tubarão - SJ/SC e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do Norte - TJ/SC, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados procedentes (fls. 334-339). A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual considerou prejudicada a análise do mérito recursal e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 434-438). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fl. 444). Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 526-532). II - **Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde - Renome/SUS. III - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. IV - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. V - **Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Renome/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin - relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.** VI - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Renome/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. VII - Ademais, no tocante à competência do Juízo estadual, tal entendimento foi**

recentemente ratificado nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo relator, Ministro Herman Benjamin. Registre-se que o voto foi acolhido à unanimidade na sessão de 9 de fevereiro, oportunidade em que tal entendimento também foi acolhido no julgamento do CC n. 174.749/PR, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria. **VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da RENAME/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.** IX - Por fim, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. X - Agravado interno improvido" (AgInt nos EDcl no CC n. 182.785/SC, relator Ministro Francisco Falcão, **Primeira Seção**, julgado em **28/6/2022**, DJe de 1/7/2022 - gn)

Nesse sentido, ainda:

"EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos. 2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seus arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide. 3. Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente." 4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. 5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. 6. **Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 7. Por fim, cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda. 8. **Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.** 9. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ. 10. Juízo de retratação rejeitado" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, **Primeira Seção**, DJe de **15/3/2022** - gn)**

Em atenção ao fato de que o litígio não envolve medicamento desprovido de registro na ANVISA, de alto custo ou integrante dos Componentes Estratégico ou Especializado (Grupo1) de Assistência Farmacêutica, a responsabilidade pelo seu fornecimento não deve ser imputada especificamente à União Federal.

(...)

Em observância ao precedente firmado pelo STF sob o Tema 793, impõe-se o evidente retorno à esfera estadual.

(...)

Assim, em casos tais, ainda que se entendesse que a inclusão da União no polo passivo teria ocorrido por requerimento da parte autora, espontaneamente, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão esbarraria no disposto no art. 329 do CPC, segundo o qual o autor não poderá alterar o pedido após o saneamento do processo:

(...)

Em conclusão, a decisão proferida pelos Juízos e Tribunais inferiores que, a pretexto de aplicar o Tema 793, determina ou acolhe a decisão proferida de ofício por outro Juízo de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e deslocamento da competência para a Justiça Federal, não encontra respaldo na tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (tema 793), inclusive porque ainda existe julgamento não concluído relativo a Recurso Extraordinário com reconhecimento de Repercussão Geral específico para o tema medicamentos não incorporados ao SUS (Recurso Extraordinário nº 566471 - Tema 6), bem como viola os artigos 44, 45, 64 (incompetência absoluta), 114 (litisconsórcio necessário), 506 (coisa julgada) e 927 (observância das teses vinculantes pelos juízos e tribunais), todos do CPC, e a tese vinculante fixada no Tema 686 pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.203.244/SC), além de violar os artigos 2º, 109, inciso I, 196 e 198 da Constituição Federal e a própria tese fixada no Tema 793 pelo STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. A decisão agravada está assim fundamentada:

(...)

3. A decisão do juízo estadual que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (evento 32, pp. 10/11) fundamenta-se na decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, em 19/4/2023, referendou decisão liminar proferida em 17/4/2023 no RE 1366243 (Tema de RG 1234), relator Ministro Gilmar Mendes, na qual foi concedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral (Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS), a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos parâmetros ali estabelecidos.

O acórdão possui a seguinte ementa:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida - que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos - quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. **5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (destacado)**

No presente caso, devem ser observados os parâmetros estabelecidos no item 5.1, uma vez que ainda não foi prolatada sentença nos autos originários.

Com efeito, conforme consta da decisão acima referida, o Estado do Espírito Santo informou que a fórmula pleiteada pela parte autora se encontra no Grupo 1A, grupo de medicamentos que é financiado exclusivamente pelo Ministério da Saúde.

A decisão ora impugnada, por sua vez, menciona que o medicamento pretendido pertence **ao Grupo 1A do CEAf** e disponibilizado no SUS.

Tratando-se, pois, de demanda envolvendo medicamento padronizado, **a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual.**

4. Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas.

No grupo 1A constam os medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

Diante disso - e sem prejuízo de análise da questão em eventual recurso inominado que venha a ser interposto em face da sentença a ser proferida na ação originária - não há como qualificar como ilegal, e muito menos considerar teratológica a decisão impugnada.

2. As razões do agravo restam afastadas em razão de estarem a decisão agravada e a decisão do juízo de primeiro grau fundamentadas na decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, em 19/4/2023, **referendou decisão liminar proferida em 17/4/2023 no RE 1366243 (Tema de RG 1234)**, relator Ministro Gilmar Mendes, na qual foi concedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que **até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral (Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS)**, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos parâmetros ali estabelecidos.

A agravante nada aduz a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas apenas sobre decisões mais remotas.

Nada aduz também quanto ao fato de que o Estado do Espírito Santo informou que a fórmula pleiteada pela parte autora se encontra no Grupo 1A, grupo de medicamentos que é financiado exclusivamente pelo Ministério da Saúde.

3. Pelo exposto, voto no sentido de **NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.**